



*BOMBEIRO: O AMIGO  
CERTO  
NAS HORAS INCERTAS*



# Psicopatologia do comportamento suicida

Major BM Richelmy Murta Pinto, DAI  
Psicólogo Clínico Esp. em Terapia Cognitivo-comportamental  
2026

# Roteiro

- ✓ Introdução;
- ✓ Objetivos deste módulo;
- ✓ Conceitos gerais;
- ✓ Psicopatologia do comportamento suicida;
- ✓ A mente do tentante na tentativa
- ✓ Principais transtornos em ATS;
- ✓ Conclusão;
- ✓ Referências.



# Introdução

Éramos jovens demais  
para entender...

@psicilenemorais



# Introdução

**Suicídio é uma escolha?**



# Introdução

***“O Suicídio é uma solução definitiva para uma questão temporária.”***

*Edwin Shneidman*

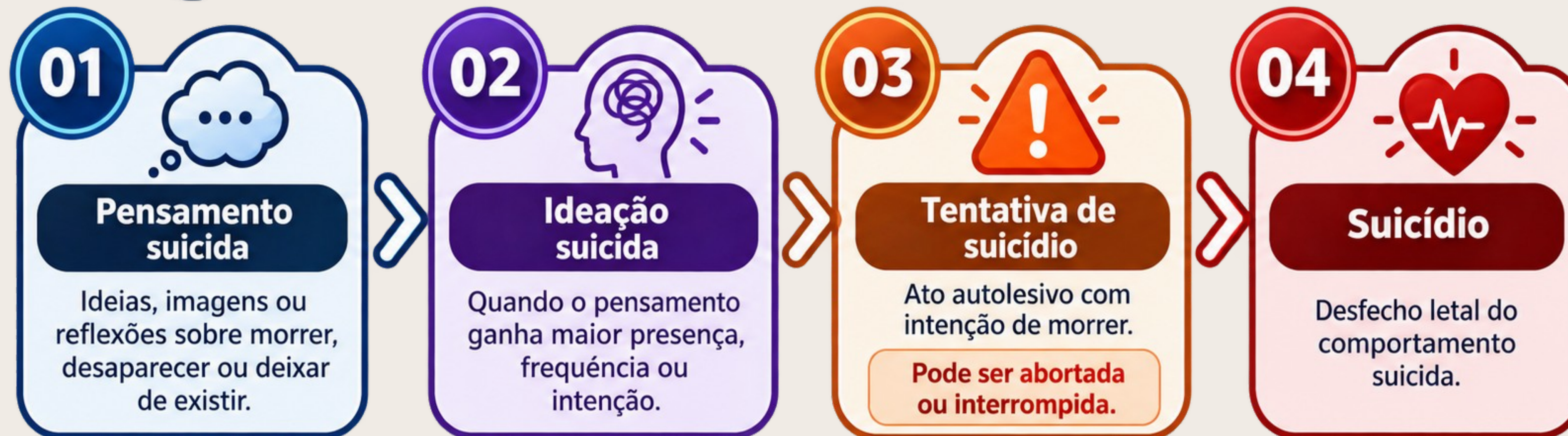


# Objetivos deste módulo

**Ao final deste módulo, você será capaz de:**

- ✓ *Entender por que o suicídio tem várias causas ao mesmo tempo;*
- ✓ *Reconhecer quando a mente perde a capacidade de decidir;*
- ✓ *Identificar os principais fatores de risco e os gatilhos;*
- ✓ *Perceber como os transtornos aparecem nas ocorrências reais.*

# Conceitos gerais



# Psicopatologia do comportamento suicida

## Causalidade



# Psicopatologia do comportamento suicida



# Psicopatologia do comportamento suicida

## Multicausalidade

- ✓ 90,7% das mortes por suicídio apresentavam transtorno mental ou sintomas psiquiátricos em estudos brasileiros de autópsia psicológica, segundo revisão sistemática nacional recente.
- ✓ 28,1% tinham tentativa prévia de suicídio, importante marcador clínico associado ao risco futuro.

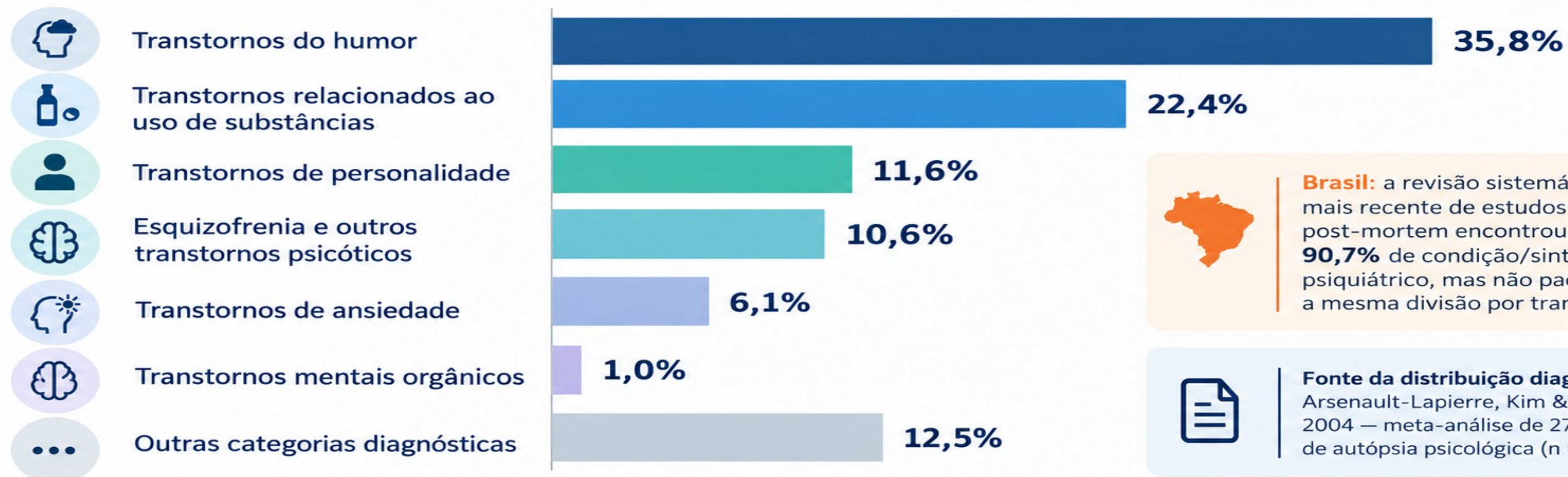


# Psicopatologia do comportamento suicida

## AUTÓPSIA PSICOLÓGICA

### Distribuição dos principais transtornos identificados em mortes por suicídio

Melhor síntese meta-analítica disponível para diagnósticos específicos



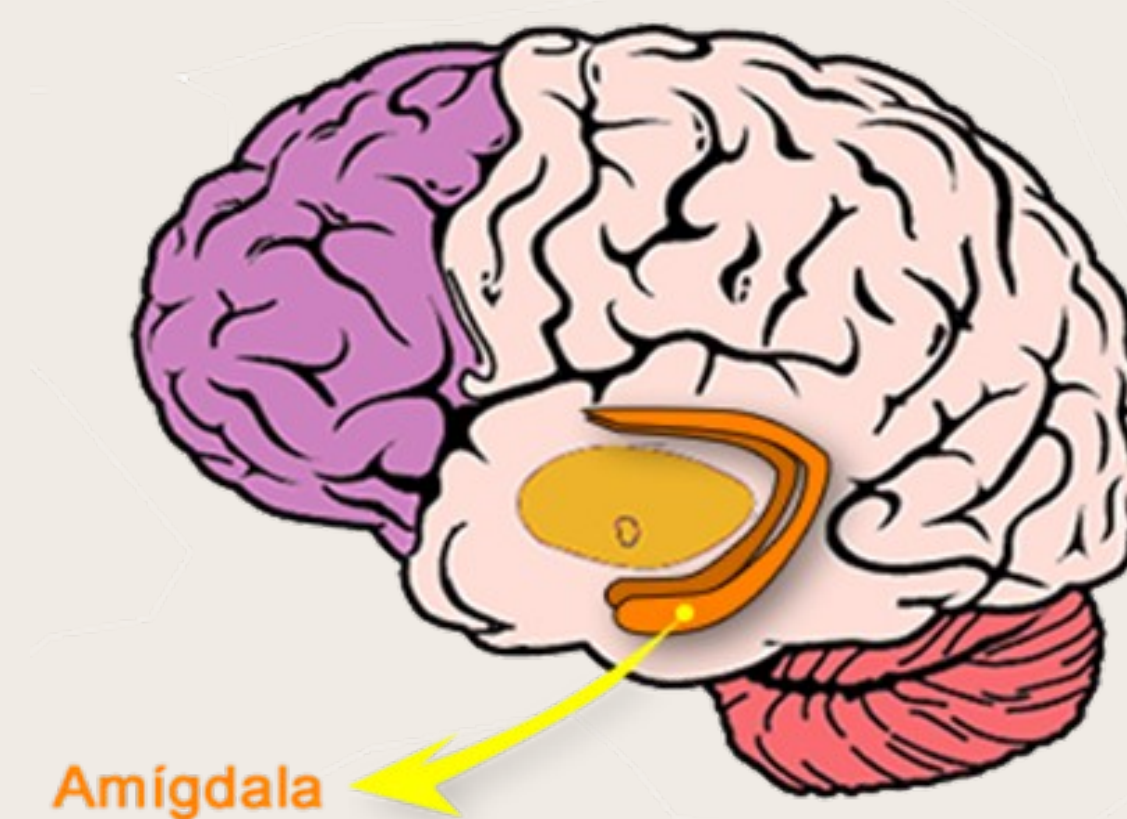
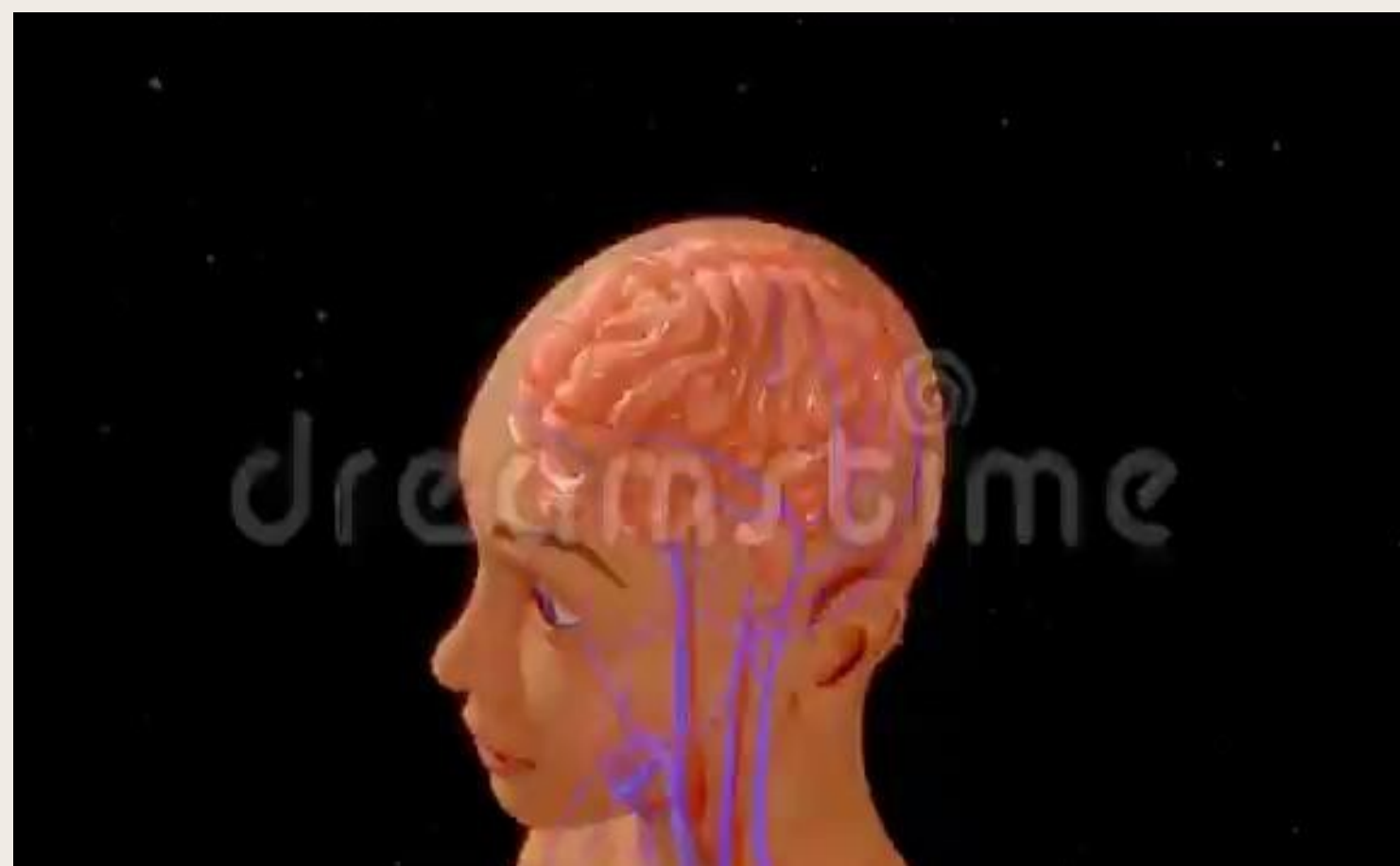
**Use em aula:** os percentuais diagnósticos não somam causalidade; indicam frequência relativa entre diagnósticos identificados.

CONHECIMENTO | PREVENÇÃO | VIDAS

# Psicopatologia do comportamento suicida

## Multicausalidade

- ✓ Preâmbulo: *Ato reflexo*;
- ✓ Controle *Top-Down* das emoções;
- ✓ Impacto emocional interfere no controle;
- ✓ Córtex pré-frontal “enfraquecido”;
- ✓ Desregulação emocional + baixo controle inibitório = impulsividade;



# Psicopatologia do comportamento suicida

**Suicídio é uma escolha?**



# A mente do tentante na tentativa

## Capacidade de julgamento e decisão

1

### Avaliação e Escolha

Capacidade de avaliar e escolher as melhores opções diante de diferentes situações encontra-se **avariada**.

2

### Ato Volitivo

Envolve a sequência contínua de **intenção, deliberação, decisão** e **execução**.

3

### Falhas Cognitivas

**Falhas** nesses processos cognitivos podem comprometer o julgamento e levar a **escolhas impulsivas e perigosas**.

4

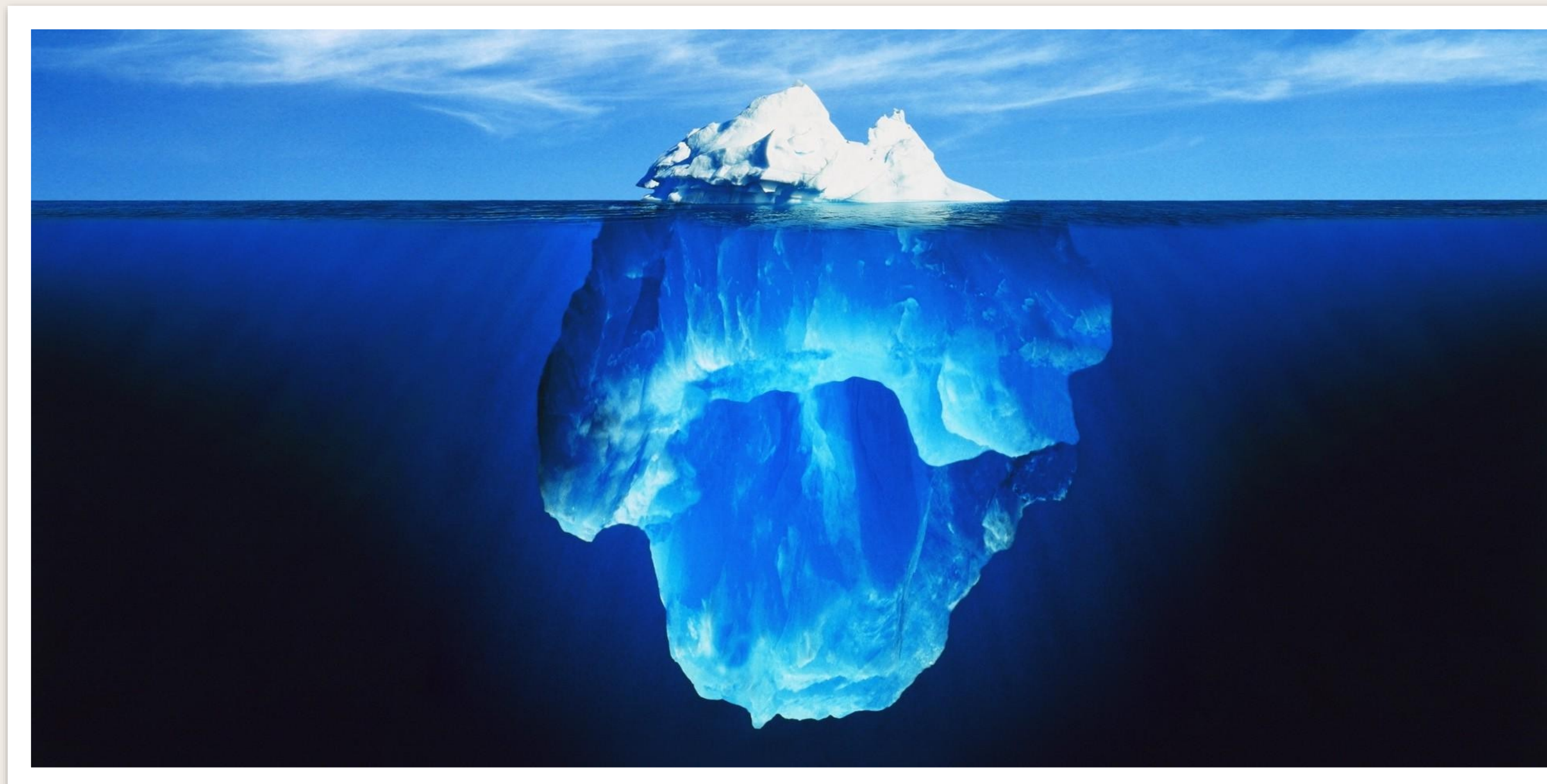
### Estado de Desprazer

Gera forte impulsividade e acelera a cadeia do comportamento com foco em **fuga imediata**.

# A mente do tentante na tentativa

## Fatores de risco

- ✓ Fatores de risco **predisponentes** (distais) ou **precipitantes** (proximais);



# A mente do tentante na tentativa

## Fatores de risco

### 1 Fatores Predisponentes (Distais / Longa Data)

Acompanham o indivíduo ao longo do tempo, aumentando a vulnerabilidade de base:

- Transtornos psiquiátricos
- Tentativa prévia de suicídio
- Histórico de suicídio na família
- Abuso sexual ou traumas na infância
- Impulsividade e agressividade
- Isolamento social prolongado
- Doenças incapacitantes ou incuráveis

### 2 Fatores Precipitantes (Proxiais / Gatilhos)

Eventos agudos que funcionam como estressor imediato para o ato:

- Desilusão amorosa ou separação conjugal
- Luto, solidão e conflitos relacionais
- Violência doméstica
- Derrocada financeira ou perda de emprego
- Sentimentos graves de desonra / vergonha
- Estado de embriaguez ou intoxicação
- Fácil acesso a meios letais

# A mente do tentante na tentativa

SAÚDE MENTAL | PREVENÇÃO | VIDA

## Comportamento suicida: síntese de dois modelos atuais

Integração do 3ST e do modelo IMV

### 3ST — Three-Step Theory

(Klonsky & May, 2015)



**1. Dor psíquica + desesperança**  
→ ideação suicida



**2. Baixa conexão / pertencimento**  
mantém ou intensifica a ideação



**3. Capacidade para a tentativa**  
(disposicional, adquirida e prática)  
aumenta o risco de ação

Ambos ajudam a  
entender como se vai  
da vulnerabilidade  
à ação

### IMV — Integrated Motivational-Volitional Model

(O'Connor & Kirtley, 2018)



**Pré-motivacional:**  
vulnerabilidades + estressores



**Motivacional:**  
derrota / humilhação → aprisionamento  
→ ideação



**Volitiva:**  
acesso a meios, planejamento, exposição,  
impulsividade e capacidade para agir

### Mensagem central

1

Ideação não é igual  
a tentativa

2

A passagem à ação depende  
de fatores volitivos e da  
capacidade para tentar

3

Vínculo, apoio, esperança e  
acesso ao cuidado funcionam  
como proteção

Fontes: Klonsky & May (2015) • O'Connor & Kirtley (2018)

CONHECIMENTO QUE SALVA VIDAS

# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno Depressivo Maior

Disfunção que causa tristeza profunda e prolongada, perda de interesse em atividades antes prazerosas, alterações do sono e do apetite, bem como pensamentos negativos e pessimismo em relação ao futuro.



# A mente do tentante na tentativa

## **Transtorno Depressivo Maior** — Correlação com Comportamento Suicida

### **Aspectos Cognitivos & Emocionais**

Pensamentos recorrentes de morte, sentimentos intensos de desesperança e percepção de incapacidade para enfrentar dificuldades.

### **Comorbidades e Riscos**

Risco significativamente aumentado de abuso de substâncias, desenvolvimento de doenças médicas graves e desencadeamento de outros transtornos mentais.

### **Estatísticas de Impacto**

**15%** dos pacientes tentam o suicídio

**50%** das mortes por suicídio ocorrem em quadros depressivos

**20x** maior risco de suicídio comparado à população geral

# A mente do tentante na tentativa

**Transtorno Depressivo Maior** — Apresentação na emergência de TAE

## Cognitivo

pensamentos lentos,  
rígidos, dominados  
por desesperança.

## Emocional

apatia intensa, vazio,  
tristeza profunda,  
desesperança  
constante.

## Comportament al

corpo retraído,  
movimentos lentos,  
pouca iniciativa  
presente.

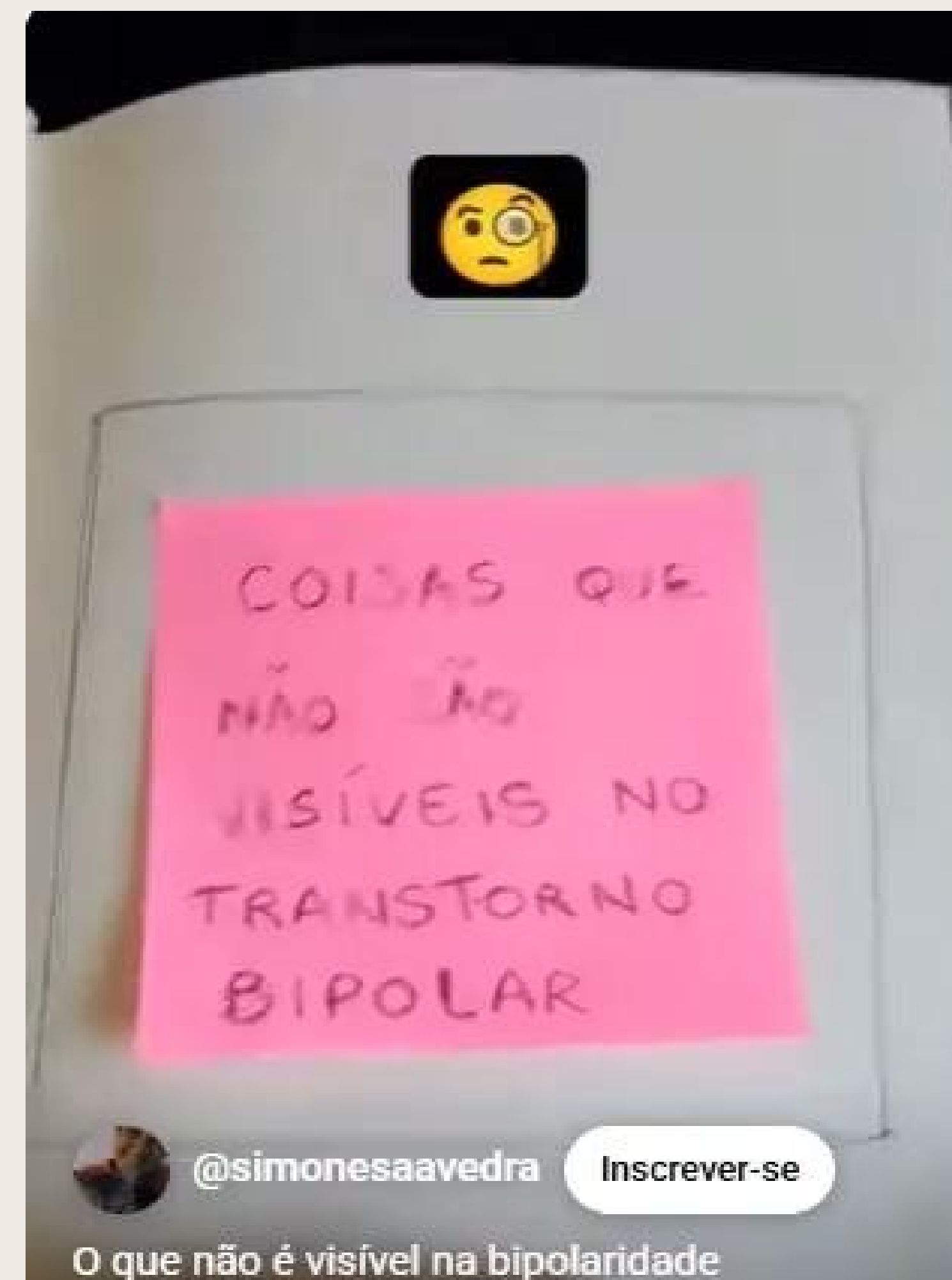
## Não Verbal

olhar baixo, silêncio  
prolongado, postura  
curvada, expressão  
apagada.

# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno Afetivo-Bipolar

Transtorno psiquiátrico crônico caracterizado por **mudanças extremas de humor**, com episódios de mania ou hipomania (fase de alta) e depressão (fase de baixa).



# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno Afetivo-Bipolar — Correlação com comportamento suicida

### Risco Geral

**15x**

TAB apresenta um risco de comportamento suicida até 15 vezes maior que a população geral.

### Fase de Mania

**Impulsividade**

O comportamento impulsivo durante a fase de mania aumenta significativamente o risco de atos suicidas.

### Letalidade

**40%**

40% da letalidade no TAB decorre da associação entre intensidade depressiva e impulsividade.

### Fase Depressiva

**13% vs 11%**

Suicídio muito presente na fase depressiva. Mortes: depressão bipolar (13%) vs unipolar (11%).

# A mente do tentante na tentativa

**Transtorno Afetivo-Bipolar** — Apresentação na emergência de TAE

## **Cognitivo** **Pensamento & Julgamento**

- Fuga de ideias
- Avaliação ruim
- Impulsividade marcada

## **Emocional** **Humor & Afeto**

- Euforia e irritabilidade
- Autoconfiança exagerada
- Agressividade ocasional

## **Comportamental** **Ação & Conduta**

- Agitação e desinibição
- Condutas de risco
- Oposição direta

## **Não Verbal** **Expressão & Postura**

- Fala rápida
- Gestos amplos
- Olhar intenso
- Inquietação

# A mente do tentante na tentativa

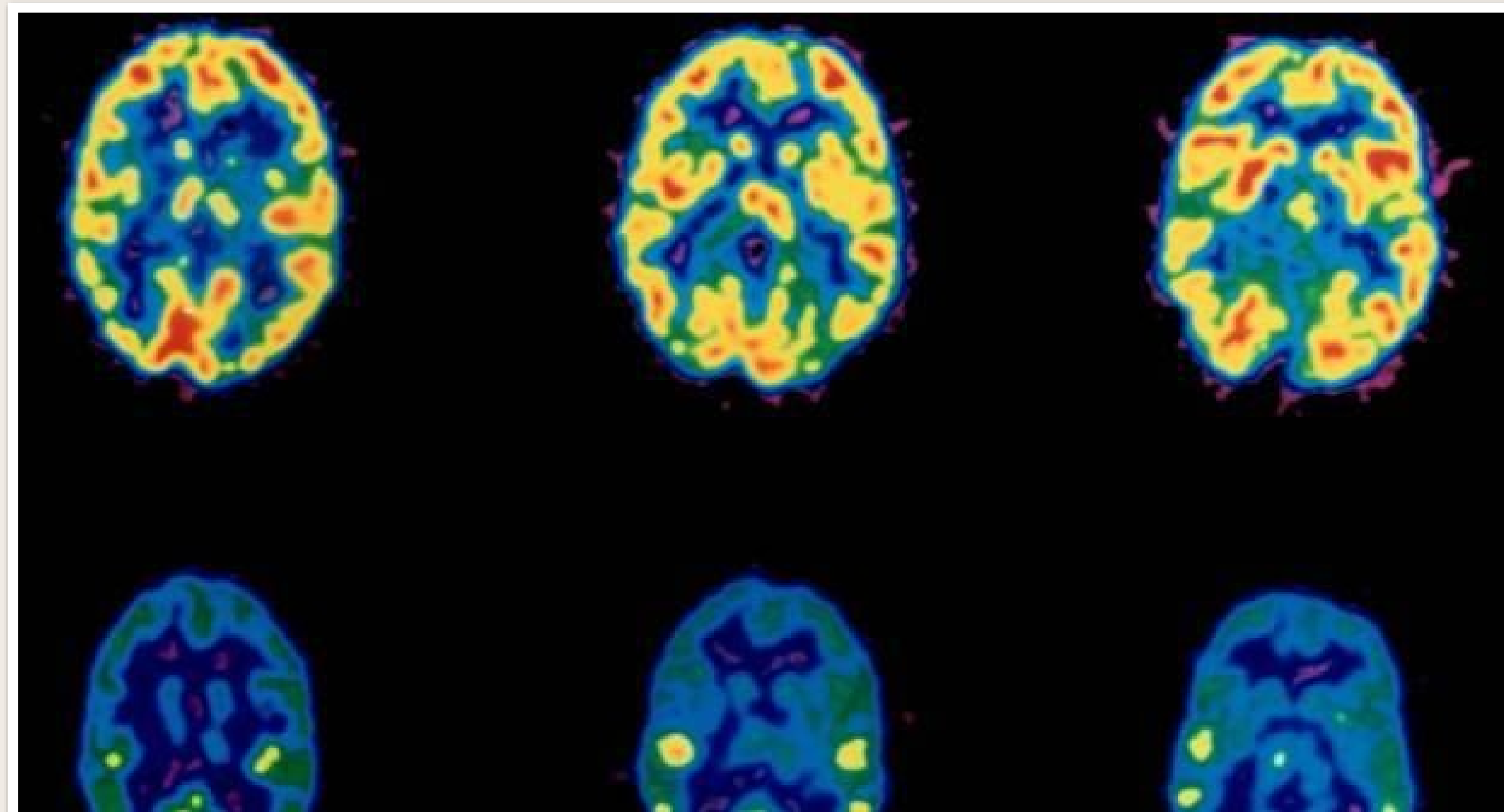
## Transtorno por Uso de Substâncias

Uso excessivo e prejudicial de substâncias psicoativas, que incluem álcool, tabaco, maconha, cocaína, opiáceos, entre outros.



# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno por Uso de Substâncias



# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno por Uso de Substâncias

Correlação com comportamento suicida:

### Impacto Cognitivo & Executivo

- Afeta memória (viés), controle executivo e motivação;
- Impulsividade associada ao córtex pré-frontal;

### Alterações Multidimensionais

- Alterações cognitivas, emocionais, fisiológicas e comportamentais;
- Presença de sintomas psicóticos;

### Compulsão & Estado Emocional

- Compulsão para busca e obtenção de substância;
- Irritação, ansiedade e impulsividade elevadas;

### Multiplicadores de Risco de Suicídio

**7x** — Alcoolistas  
**4x a 20x** — Dependentes químicos (variando conforme a droga)

# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno por Uso de Substâncias

Apresentação na emergência de TAE:

### **Cognitivo**

pensamento confuso, julgamento prejudicado, percepção distorcida, desatenção.

### **Emocional**

instabilidade marcada, irritabilidade, impulsividade, agressividade acentuada.

### **Comportamental**

atos imprevisíveis, resistência à contenção, risco de violência.

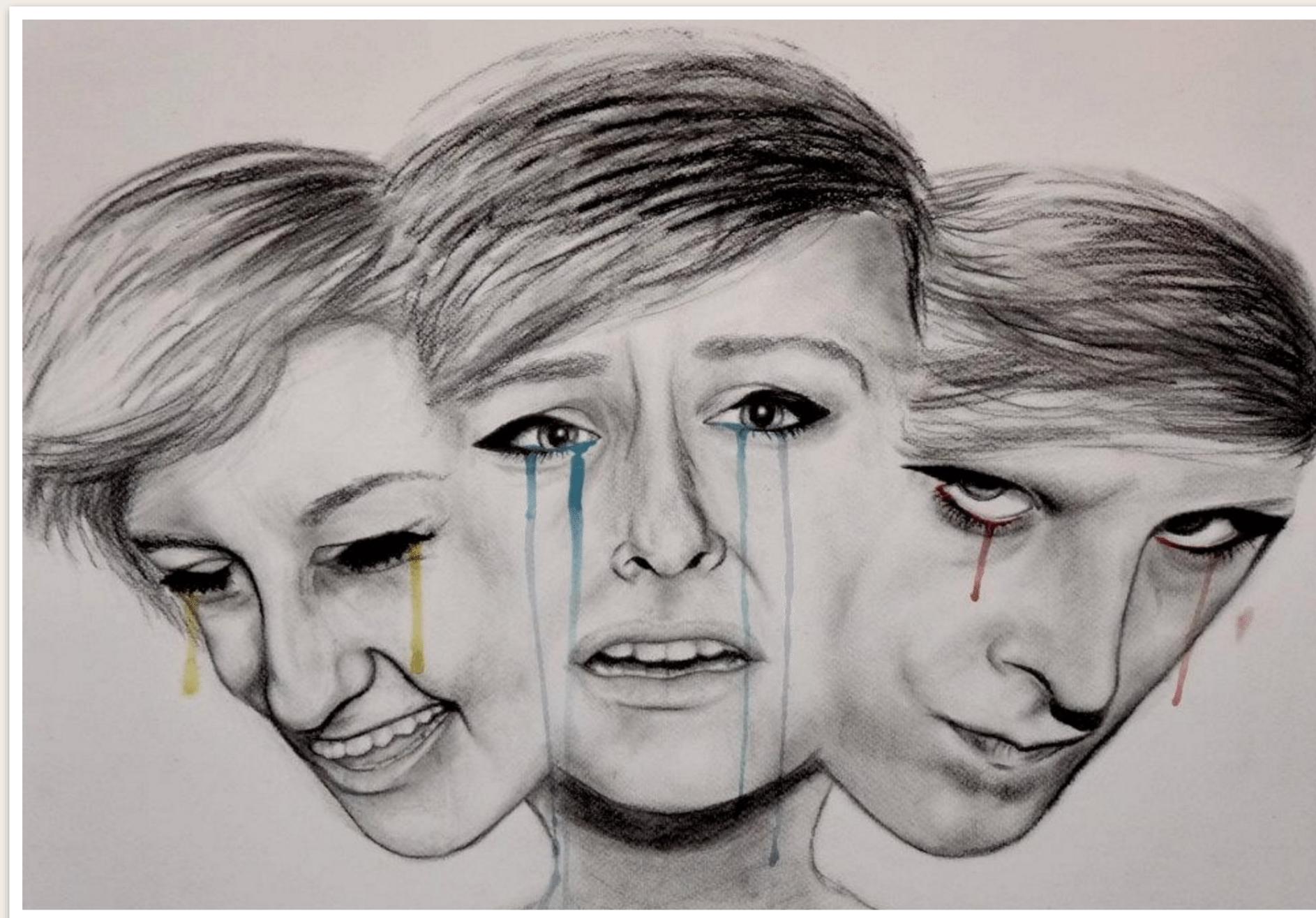
### **Não verbal**

fala incoerente, olhar perdido, agitação motora, gestos bruscos.

# A mente do tentante na tentativa

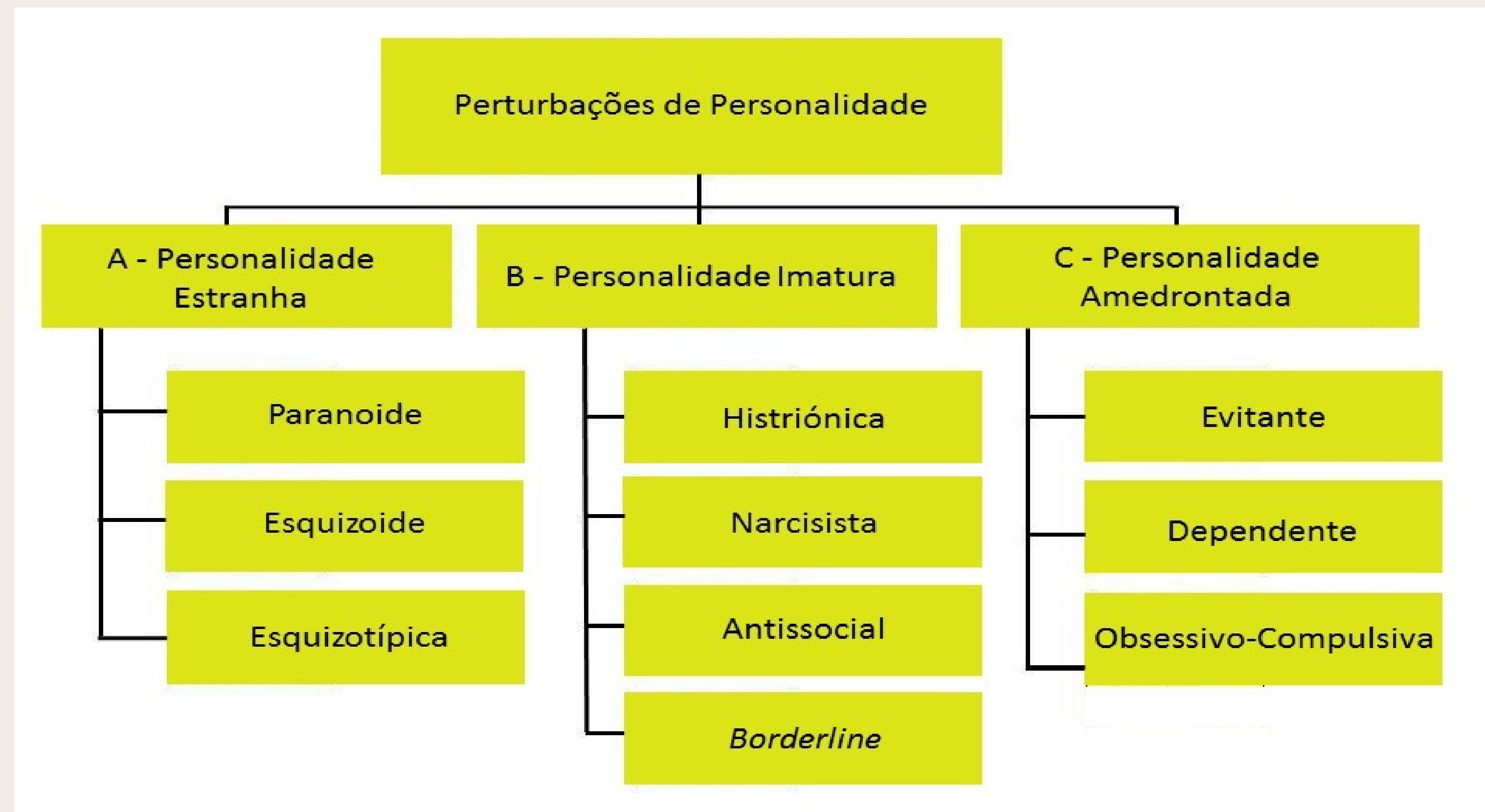
## Transtornos de Personalidade

Padrões rígidos e duradouros de pensar, sentir e agir, que dificultam relações, aumentam conflitos e podem gerar reações extremas em situações de estresse.



# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos de Personalidade



# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos de Personalidade

### Grupo A

Pessoas desconfiadas, retraídas, frias, com pouco vínculo afetivo.

### Grupo B

Intensas, instáveis, impulsivas, dramáticas, agressivas ou desafiadoras.

### Grupo C

Ansiosas, medrosas, inseguras, com grande dificuldade no cotidiano.



# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos de Personalidade

Correlação com comportamento suicida

### Borderline

Pacientes mais propensos ao risco devido à combinação de comportamento emocional instável e alta impulsividade.

**20%**

tentam suicídio ao longo  
de 2 anos

**3x**

em média de  
tentativas ao longo  
da vida por paciente  
diagnosticado



# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos de Personalidade

Apresentação na emergência de TAE:

### Cognitivo

visão “tudo ou nada”,  
abandono, rejeição,  
raiva.

### Emocional

oscilações fortes,  
desespero,  
explosividade, raiva  
contra si/outros.

### Comportamenta l

atos dramáticos,  
teatralidade,  
automutilação, risco  
recorrente.

### Não verbal

gestos amplos, choro  
intenso, postura  
desafiadora,  
expressões fortes.

# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos Psicóticos

Transtornos mentais que afetam a capacidade de uma pessoa de pensar, sentir e se relacionar com os outros de forma racional e clara.



# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos Psicóticos

### Sintomas & Cognição

Delírios, alucinações, comportamentos desorganizados e alterações cognitivas.

### Impacto Funcional

Sintomas graves: prejuízos significativos no funcionamento ocupacional, social e pessoal.

### Critérios Diagnósticos

O diagnóstico também leva em conta o tipo e gravidade dos sintomas, a duração e o impacto na vida diária do paciente.

# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos Psicóticos

Correlação com comportamento suicida:

### Ideação & Desesperança

Desesperança, desamparo e ideação suicida frequentes.

### Desorganização Cognitiva

O alto nível de angústia e desorganização cognitiva levam a comportamento impulsivo + tomada de decisões arriscadas.

### 8,5x Risco em Esquizofrênicos

Elevação expressiva do risco; 5% morrem utilizando métodos bizarros.

### 40% Tentativas de Suicídio

Dos pacientes psicóticos tentam o suicídio (sendo que 9% a 13% progridem para óbito).

# A mente do tentante na tentativa

## Transtornos Psicóticos

Apresentação na emergência de TAE:

### Cognitivo

Pensamento desorganizado, delírios persecutórios ou místicos, raciocínio fragmentado.

### Emocional

Medo intenso, angústia persecutória, desesperação, descontrole afetivo.

### Comportamental

Condutas bizarras, resistência ao contato, risco de violência.

### Não Verbal

Olhar alucinado, murmúrios, postura defensiva, agitação motora.

# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno do Estresse Pós-Traumático

Transtornos mentais que se desenvolvem após uma experiência traumática, que resulta em sintomas de evitação, pensamentos intrusivos e perturbadores, humor depressivo e hipervigilância.



# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno do Estresse Pós-Traumático

### Exposição

Exposição a um ou mais eventos traumáticos.

### Sintomas

Manifestação de **revivescência** do evento, **evitação** de estímulos e **hipervigilância**.

### Duração

Duração dos sintomas por mais de um mês (TEA – até 30 dias).

### Prejuízo

Prejuízo significativo na vida pessoal e profissional do indivíduo.



# A mente do tentante na tentativa

## Transtorno do Estresse Pós-Traumático

### Trauma como Elo

O trauma atua como elo central para o desenvolvimento de outros transtornos: **TEA, TEPT, depressão, TAG, dependências, pânico** e comportamentos suicidas.

### Comorbidade Significativa

**88,3%**  
dos homens **79%**  
das mulheres

### Elevação do Risco de Suicídio

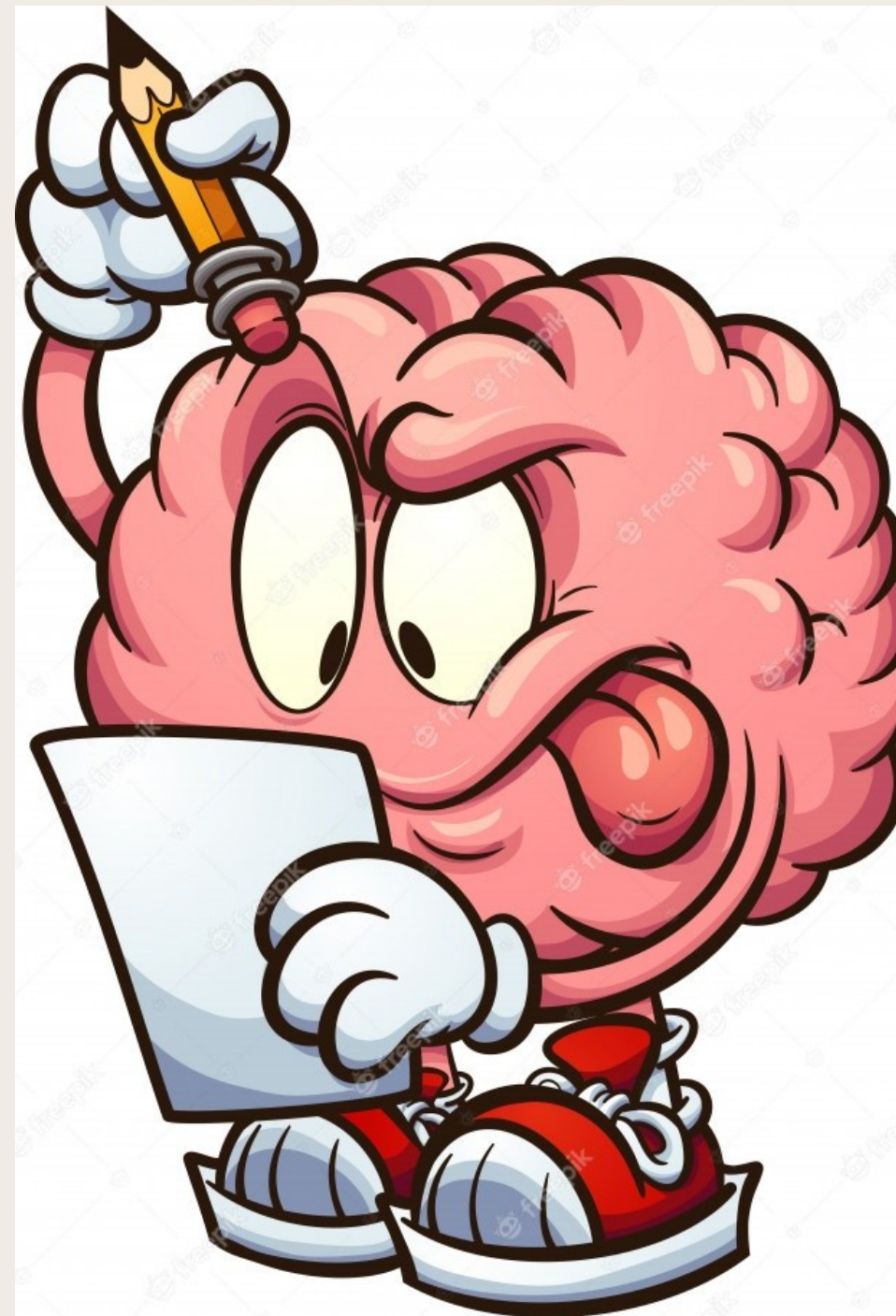
**3 a 5x** mais *ideação suicida*  
**3 a 6x** mais risco de *tentar suicídio*  
Em comparação àqueles que não desenvolvem o transtorno.

### Isolamento & Evitação

A **evitação social** e o **isolamento** atua como agravantes críticos, podendo aumentar ainda mais o risco de comportamento suicida.

# Conclusão

**Então quer dizer que...**



# Conclusão

## Então quer dizer que...

- ✓ *Comportamento suicida resulta de múltiplos fatores interagindo juntos;*
- ✓ *A mente do tentante apresenta julgamentos gravemente comprometidos;*
- ✓ *Identificar sinais clínicos permite abordagem mais segura e empática;*
- ✓ *Compreender transtornos amplia leitura e eficácia nas ocorrências.*

# Fim!

## Seja a diferença

"A paciência é a mais heróica  
das virtudes, justamente por  
não ter nenhuma aparência de  
heroísmo."

*Giacomo Leopardi*



# Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais**: (DSM-5). 5º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 948 p.

BOTEGA, N. J. **Crise Suicida**: Avaliação e manejo. 1ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 302 p.

DALGALARRONDO, Paulo. **Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais**. 3º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 505 p.

MARBACK, R.F.; PELISOLI, C. **Terapia cognitivo-comportamental no manejo da desesperança e pensamentos suicidas**. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, Rio de Janeiro, v. 10, ed. 2, p. 122-129, 17 dez. 2014.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. **Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil e a rede de atenção à saúde**. Boletim Epidemiológico, Brasília, v. 48, ed. 30, 21 dez. 2017.

QUEVEDO, J.; IZQUIERDO, I. **Neurobiologia dos transtornos psiquiátricos**. 1º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. 392 p.

WENZEL, Amy; BROWN, GREGORY K.; BECK, Aaron T. **Terapia cognitivo-comportamental para pacientes suicidas**. Porto Alegre: Artmed, 2010. 304 p.

# Referências

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. **Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil e a rede de atenção à saúde**. Boletim Epidemiológico, Brasília, v. 48, ed. 30, 21 dez. 2017.

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ofício nº. 34/2020 - CBMMG/CINDS. **Dados de Registros de Vítimas e de ocorrências relacionadas a suicídio atendidas pelo CBMMG**, Belo Horizonte: EMBM2, ano 2020, 18 jul. 2020.

\_\_\_\_\_. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. **Registro de Ocorrências atendidas pelo CBMMG**, Belo Horizonte: EMBM3, ano 2020, 18 set 2020.

SCAVACINI, K. **O suicídio é um problema de todos**: consciência, a competência e o diálogo na prevenção e posvenção do suicídio. Orientador: Maria Júlia Kovács. 2018. 271 f. Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

STERN, T.A. *et al.* **Tratado de psiquiatria clínica**. 2ª. ed. Barcelona: Elsevier, 2016. 1039 p.

WENZEL, Amy; BROWN, GREGORY K.; BECK, Aaron T. **Terapia cognitivo-comportamental para pacientes suicidas**. Porto Alegre: Artmed, 2010. 304 p.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Preventing suicide: A global imperative**. Geneva: [s. n.], 2014.